



CACREF Salud

Censo socioeconómico, salud y bienestar para colaboradores PDVSA/FUTPV

Mensaje central

La plataforma permite pasar de una ayuda reactiva y dispersa a una gestión ordenada, auditable y financieramente responsable: ayudar mejor, priorizar con evidencia y construir programas recurrentes sin comprometer el equilibrio económico de CACREF.

85

Registros demo

30

Medicamentos

19

Cirugías

53

Riesgo alto

Preparado para Junta Directiva / Directivos CACREF

Fecha: 30/07/2026 | Versión ejecutiva

Decisión solicitada

- Aprobar el uso del censo como herramienta institucional de diagnóstico y priorización.
- Autorizar un piloto controlado con responsables, reglas de acceso y tablero directivo.
- Ratificar aporte base de 2% para inscritos y definir topes, reserva y cálculos posteriores.
- Iniciar negociación con proveedores de medicamentos, laboratorios, clínicas y servicios asociados.

1. Objetivo y norte institucional

Objetivo	Crear una base única y confiable para identificar necesidades reales de trabajadores, afiliados CACREF y familiares, priorizar casos por urgencia administrativa y construir programas sostenibles de apoyo.
-----------------	--

El norte no es entregar ayudas sin control. El norte es combinar solidaridad cooperativa con data, aporte base de 2% para inscritos, convenios y trazabilidad. Los préstamos u otros programas se calculan luego según política, capacidad y aprobación.

Situación actual	Con CACREF Salud
Solicitudes dispersas por llamadas, planillas o mensajes	Formulario único con datos comparables
Decisiones caso a caso con información incompleta	Scoring administrativo y cola priorizada
Poca trazabilidad de revisión y aprobación	Workflow, auditoría e historial por caso
Riesgo de prometer más de lo financiable	Topes, reserva técnica y decisión por comité

2. Capacidad ya desplegada

- Formulario público de cuatro pasos: identidad, vinculación, economía, salud y calidad de vida.
- Dashboard administrativo con KPIs, filtros, detalle de casos, documentos, comentarios y workflow.
- Roles diferenciados: capturista, vocal, presidente y director.
- Consulta pública por cédula, transparencia agregada y políticas de privacidad.
- Backend local y producción: SQLite/Turso, Express/Netlify Functions, autenticación y bitácora.

Alcance correcto	La plataforma no diagnostica, no sustituye evaluación médica y no aprueba beneficios automáticamente. Ordena información y prepara decisiones para el comité.
-------------------------	---

3. Datos, score y lógica de priorización

El score es administrativo. Su función es ordenar la cola y transparentar por qué un caso requiere atención antes que otro. La decisión final sigue siendo humana, institucional y documentada.

Componente	Uso en la decisión	Resultado esperado
Antigüedad y vinculación	Reconoce trayectoria y pertenencia cooperativa	Prioridad con sentido institucional
Capacidad de aporte	Evita cuotas impagables	Sostenibilidad y menor mora
Medicamento crónico	Identifica necesidad recurrente	Programas de abastecimiento y convenios
Cirugía/procedimiento	Detecta casos de alto impacto	Revisión por comité y topes
Calidad de vida	Mide vulnerabilidad percibida	Semáforo social de bienestar

Salidas del sistema: riesgo bajo/medio/alto, recomendación administrativa, prioridad numérica, cuota máxima sugerida y estado del workflow.

4. Lectura de la base de demostración

85 Total casos	53 Riesgo alto	25 Riesgo medio	7 Riesgo bajo
Indicador demo	Valor	Lectura directiva	
Medicamentos crónicos	30	Demanda recurrente que puede negociarse por volumen	
Cirugías/procedimientos	19	Casos de alto impacto que requieren topes y comité	
Familiares con asistencia	13	Carga familiar que afecta calidad de vida y estabilidad	
Calidad de vida promedio	3.29	Línea base para medir mejora trimestral	
Aporte mensual promedio	517.53	Referencia para calibrar programas sostenibles	

Nota: los datos son de demostración local para validar capacidad operativa; la campaña real debe iniciar con piloto controlado.

5. Modelo recurrente sin números rojos

Regla financiera de control	El 2% opera como aporte base de inscritos. Ingresos recurrentes - ayudas directas - costos operativos - reserva técnica >= 0. Préstamos y programas especiales se calculan aparte.	
Palanca	Cómo crea valor	Control de riesgo
Aporte base 2%	Financia operación inicial y reserva	Base recurrente para inscritos
Cálculos posteriores	Préstamos y programas especiales	Según capacidad, topes y aprobación
Convenios proveedores	Más casos atendidos con el mismo fondo	Precios negociados y cupos
Fondo solidario	Cubre casos de alto impacto	Reserva mínima obligatoria
Scoring y workflow	Evita asignaciones improvisadas	Comité, SLA y auditoría

6. Ejemplo financiero referencial

Variable	Escenario ilustrativo	Uso directivo
Participantes	1.500 afiliados	Dimensionar recaudación potencial
Aporte base inscritos	2%	Referencia institucional recurrente
Base promedio ilustrativa	300 USD equivalentes	Permite estimar recaudación
Aporte resultante	6 USD equivalentes	2% de la base ilustrativa
Recaudación mensual	9.000 USD equivalentes	Techo mensual de gestión
Reserva técnica	20% = 1.800	Protección contra picos de demanda
Operación/plataforma	10% = 900	Costo de administrar bien
Fondo de ayudas	6.300	Monto disponible antes de convenios

El ejemplo no cambia la política: usa 2% como aporte base y deja préstamos o programas especiales para cálculo posterior.

7. Métricas para dirigir el programa

Categoría	Indicadores clave
Impacto social	Personas censadas, familias alcanzadas, medicamentos, cirugías, casos resueltos, variación de calidad de vida
Gestión operativa	Tiempo registro-comité, tiempo comité-resolución, SLA vencidos, carga por miembro, documentos completos
Sostenibilidad	Aporte promedio, recaudación mensual, mora, costo por caso, descuento proveedor, reserva, siniestralidad
Transparencia	Casos por estado, auditoría, decisiones documentadas, métricas agregadas sin datos personales

8. Hoja de ruta

1. Piloto controlado: validar preguntas, consentimiento, roles y primer tablero directivo.
2. Operación del comité: estados, comentarios, archivos, SLA y reportes.
3. Convenios y programas: medicamentos crónicos, cirugías, apoyo familiar y bienestar.
4. Modelo recurrente: aporte base 2%, reserva técnica, topes y medición trimestral.
5. Escala: padrón real, proveedores integrados y reportes comparativos por periodo.

9. Gobernanza mínima

- Responsables con permisos definidos y trazabilidad.
- Política de topes por tipo de apoyo.
- Reserva técnica mínima antes de comprometer nuevos desembolsos.
- Revisión jurídica del tratamiento de datos sensibles.
- Reporte directivo mensual durante piloto y trimestral en operación.

10. Cierre para directivos

CACREF Salud permite pasar de ayuda reactiva a gestión institucional: medir, priorizar, decidir, ejecutar y auditar. Para los colaboradores PDVSA/FUTPV representa una ruta clara para presentar necesidades reales. Para CACREF representa una plataforma para construir programas recurrentes con reglas financieras, reserva, convenios y control de riesgo.

Mensaje final

Ayudar más no debe significar gastar sin control. Con datos y gestión, CACREF puede ampliar impacto social y proteger la sostenibilidad económica de la cooperativa.

Decisiones inmediatas

1. Aprobar piloto institucional.
2. Nombrar comité y perfiles de acceso.
3. Validar legalmente privacidad y consentimiento.
4. Ratificar 2% base, topes y reserva inicial.
5. Autorizar negociación con proveedores de salud.